

안이비 12주차 써머리

01 인후과 총론

제 1장) 인후의 구조와 기능

★ 인두와 후두의 생리작용에 대해 쓰시오. (04,12) --> 악마 참고!

★ 후두의 방어작용에 대해 설명하시오. (03) --> 악마 참고!

1. 인두(pharynx)의 구조

- 두개저에서 비강, 구강을 지나 후두와 식도 입구까지 이르는 하나의

腔洞

- 척추와 구체적인 높이

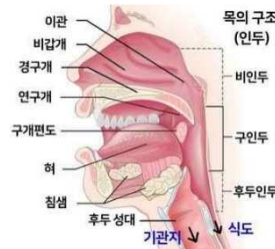
鼻部는 제1~2 경추, 口部는 제3 경추, 喉頭部는 제4~5 경추, 食道

입구부는 제6~7 경추 높이에 해당.

- 상인두는 鼻咽頭, 중인두는 口咽頭, 하인두는 喉咽頭로 구분.

- 상인두와 중인두는 연구개하연에 의해서, 중인두와 하인두는 후두개상연에 의해서 구분.

★ 상인두와 중인두는 ()으로 구분되고, 중인두와 하인두는 ()으로 구분된다. (08,04)



1) 上咽頭(epipharynx or nasopharynx)

- 鼻咽頭, 비인강. 연구개의 상부에 해당.

- 앞쪽은 후비공에 의하여 비강과, 아래쪽은 연구개가 경계를 이루며 인두협에 의하여 중인두와 통함.

- 상벽: 인두천개로 제1 경추의 높이. 인두편도선(adenoid; pharyngeal tonsil) 위치.

① 소아기에서 흔히 병적인 비대 - 腺樣增殖症(adenoid 증식증).

② 상벽이 후벽으로 이행하는 각도 : 성인은 대략 직각, 초생아는 둔각.

성인들은 직각이기 때문에 조그만 염증에도 코막힘이 쉽게 발생한다.

좁고 긴 管을 만들기 때문에 후비관이라 하며 이 때문에 가벼운 염증에서도 쉽게 비폐색을 일으킴.

- 측벽: 이관인두구가 개구. 주위에 이관융기 및 이관편도(tubal tonsil). 이관융기의 아래쪽으로 주행하는 점막주름인 인두측삭이 위치.

2) 中咽頭(mesopharynx or oropharynx)

- 경구개의 수평선과 설근의 수평선 사이. 설근부에 해당

- 전방은 구강과 통하며 양쪽에 전,후구개궁이 있고 그 사이 구개편도

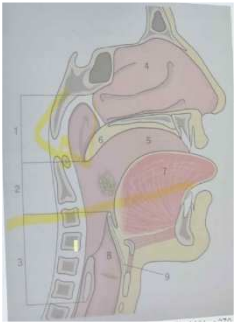
- 설근부: 설편도(lingual tonsil)

- 인두측삭: 인두 측벽과 후벽사이의 임프조직으로 상인두에서 연장되어 있음

- 연구개: 경구개의 연장으로 점막으로 덮인 잘 움직이는 근육. 안정시 설근을 향해 드리워져 있다가 음식물 통과시나 발음시 인두후벽에 붙어 상인두를 중인두로부터 분리시킴

3) 下咽頭(hypopharynx or laryngopharynx)

- 인두의 최하부, 후두 및 식도 입구부까지
- 위경계는 후두개연골의 상단 높이, 아래경계는 제 4 ~ 6 경추 높이에 해당. 그 아래 식도의 입구가 윤상연골 하연의 수평에서부터 시작
- 전하방에 후두 입구, 위쪽에 후두개위치
- 이상와: 후두의 양쪽에서 식도로 이행하는 함몰부, 이물이 잘 들어감. 양 이상와 사이에 윤상연골이 위치 *나중에 나오는 악마 문항의 설명에 해당



- 1-2번 척추: 상인두
- 3번 척추: 중인두
- 4-5번 척추: 하인두

4) 咽頭の 粘膜

- 상인두(섬모상피), 중. 하인두(중층편평상피). 점막 아래- 점액선(咽頭腺).
- 나이가 들면 점액선 분비가 저하되어 건조감 多 --> 기관까지 건조해지면 쉼쉼거리게 된다.
- 편도선: 淋巴小節이 여러 개 모임
- 상인두(인두편도선, 이관편도선), 중인두(구개편도선, 설편도선), 이외 후두편도(후두개의 내면과 가성대에 있는 淋巴小節)가 있고 인두축삭에도 淋巴小節이 산재.

5) 咽頭の 筋肉

- 내층과 외층. 내층은 縱走筋(인두를 위로 끌어올리는 인두거근), 외층은 輪走筋(인두를 수축시키는 근육).
- 후두에서는 외층이 끌어올리는 근육, 내층이 수축시키는 근육(인두와 정반대)

6) 咽頭の 神經

- 운동신경: 설인신경, 미주신경, 부신경 및 삼차신경의 제3지(하악신경).
- 지각신경: 미주신경(상후두신경), 부신경, 설인신경 및 삼차신경 제2지(상악신경). 인두신경 총 형성.

7) 咽頭の 血管

- 동맥: 외경동맥의 분지인 상행인두동맥과 소수의 안면동맥과 악동맥에서 나오는 혈관.
- 정맥: 내경정맥과 총경정맥.

2. 기능

1) 연하작용(deglutition)

- 중인두, 하인두는 소화관의 일부.
- 저작된 음식물이나 유동체는 타액과 함께 먼저 구강에서 인두로 들어가는 제1단계와 이어서 인두에서 식도로 보내지는 제2단계의 연하운동으로 이루어짐.
- (1) 1단계: 음식물이 구강에서 인두로 운반되는 과정(의식적으로 진행)
- (2) 2단계: 음식물이 인두에서 식도입구로 운반되는 과정(무의식적으로 진행)

2) 보호작용(Protection)

- 생체의 방어전선, 인두점막이 防腐 및 中和作用을 하고 이물이 붙으면 인두점막의 반사작용에 의하여 객출.

3) 공명작용(voice resonance)

- 비강 및 구강과 더불어 공명작용. 특히 구개수의 운동으로 비강을 차단 혹은 개방함으로써 鼻音과 관련이 깊다.

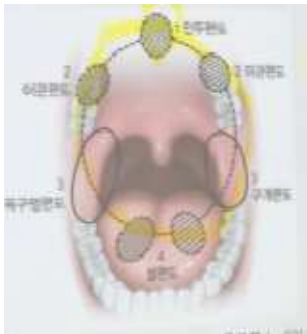
4) 호흡기류의 통로(respiration)

- 상인두는 기도의 역할만을, 중인두는 기도와 동시에 음식물의 통로.
- 호흡시 구개수는 약간 하강하여 비인강과 중인두 사이에 통로를 이루어 氣流가 통과.
- 인두점막이 온도와 습도를 조절하고 먼지를 제거하는데 도움.

2.扁桃(tonsil)

★ 편도의 구조 및 기능에 관하여 설명하시오. (00) / 편도의 종류, 방어기능설 설명(02)

1. 구조



- 인두점막 속에 발달된 림파세포인 濾胞의 집합체, 편도선.
- 왈다이엘씨 편도환(Waldeyer's tonsillar ring): 구개편도, 인두편도, 설편도, 이관편도 및 작은 편도나 고립된 림파여포가 인두를 마치 고리모양인 環狀으로 둘러싸고 있음.
- 편도의 구조는 림파선과 비슷하나 유출림파관은 있고 유입림파관은 없다.
- 편도의 지각신경(설인신경과 삼차신경의 분지), 혈관(안면동맥의 편도분지).
- *좌측 사진의 점선 모양의 큰 원 = 왈다이엘씨 편도환

1) 口蓋扁桃(palatine tonsil)

- 중인두의 양측벽 전,후구개궁에 의해 둘러싸여 이루어지는 편도와에 위치. 편도 중에서 가장 크다.
- 형태 : 다소 편평한 타원형.
- 편도피막(tonsillar capsule): 편도와 속에 파묻혀 있는 부분, 즉 편도의 외측면을 덮고 있는 막으로 구개편도의 4/5를 둘러싸고 있는 인두근막의 일종. 백색의 얇은 결체조직이며 치밀한 疎性組織으로 편도근층과 실질을 분리. 특히 편도주위농양이 이 곳에 호발. ⇒ 편도피막 때문!

2) 咽頭扁桃(Adenoid)

- 비인강의 상후벽에 위치. 편도에는 5~9개의 세로 주름이 있는데 이 주름에 많은 수의 림프여포가 위치. 소아에서 병적으로 비대하여 아데노이드 증식증을 유발, 사춘기에 들어서 위축됨.

3) 舌扁桃(lingual tonsil)

- 설근의 표면에 좌우 대칭적으로 배열되어 있는 원형 또는 타원형의 소형 림파여포.

설편도는 앞에서는 잘 안 보임

2. 기능

(1) 방어기능설(Virchow)

- ① 소화기 호흡기 입구를 윤상으로 막음, 조직이 항체생산에 관계되는 세포로 구성
- ② 림프류(流)는 수출관은 있으나 수입관이 없음
- ③ 세균의 편도 침입시 반응성 비대를 일으키며, 싸워 이기면 편도는 작아짐
- ④ 편도는 점막 바로 아래 위치하고 림프액의 흐름이 안에서 밖으로 유지됨: 세균침입시 림프 흐름에 역행을 해야 함
- ⑤ 점막 바로 아래의 균체(菌體)는 붕괴되어 분말상으로 존재
- ⑥ 면역력 약한 연소기에 발육비대되고, 점차 성장하여 저항력 증가되면 편도 퇴화

- ⑦ 어린 사람의 편도조직 속에 γ -globulin이 많이 포함. 면역항체의 생성이 왕성함을 의미
- ⑧ 간헐적 염증 편도군이 무염증성 편도군보다 γ -globulin이 증가
- ⑨ 급성 염증시 편도내 γ -globulin 의 증가

(γ -globulin의 증가 --> 면역 기능 up) (잔병치레자주하면 오래산다~)

(2) 세균침입구설

- 편도는 인체에서 유해무익함. 세균이 침입하여 패혈농독증, 심낭염, 류마티스 등 원인불명의 질환을 유발시킨다는 설.

(3) 소화기능 및 효소작용설

- lipase의 분비, amylase, diastase, tryptase 등을 함유

(4) 비타민 생성설

- vitamin A 및 C의 함량이 다른 장기에 비해 많음

(5) 조혈기능설

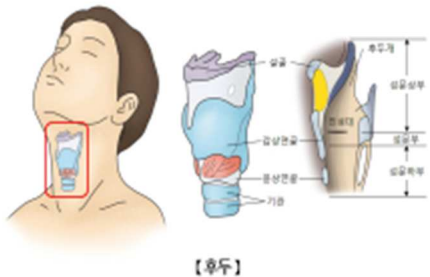
- 편도내 많은 여포가 있는데 이는 백혈구의 신생을 의미

(6) 내분비기능설

3. 喉頭(laryngeal)

1. 구조

인두와 기관 사이. 몇 개의 연골로 구성. 그 주위를 인대, 근 및 점막으로 결합된 筒狀의 삼각추체 모양으로 안쪽에는 성대가 포함되어 있는 후두강을 형성.



- 후두연골:

- ① 주요연골 3종류: 1개의 갑상연골, 1개의 윤상연골, 2개의 피열연골.
- ② 보조연골: 1개의 후두개연골, 2개의 소각연골, 2개의 설상연골.

(좌측 사진)

*후두 맨 뒤의 U자가 설골

*후두 아래는 기관

- 위치: 경추의 정중위 안정시에 상부는 제4 경추의 상단에, 하부는 제6 경추의 하단에 해당. 어린이는 제 3~4 경추 높이에, 노인들은 후두하단이 제 7 경추 높이에 있을 수도 있다.
 - 전면이 피부 바로 아래에 있고 돌출하여 “Adam’s apple”이라고 하는 후두용기를 형성.
- Adam’s apple: 갑상연골 앞의 돌출된 부분

1) 후두연골

(1) 甲狀軟骨(thyroid cartilage)

- 후두연골 중 가장 크다. 좌우의 부정방형판으로 구성. 후두 전측부의 대부분을 차지.
- 상부의 중앙에 삼각상절흔. 남자에서 후두용기(Adam’s apple) : 임상적으로 수술시 후두의 위치와 염증성 과정을 판정하는 데 기준이 되므로 중요
- 연골판의 외측 상단의 上角은 설골 大角 및 인대와, 하단의 下角은 윤상연골과 연결.
- 후두를 보호하며 발성조절에 참가함.

(2) 輪狀軟骨(cricoid cartilage)

- 갑상연골과 제1기관륜 사이의 연골. 완전한 指輪狀, 후두강을 유지하는데 중요.
- 상연에 피열연골과 결합하는 관절면이, 판부나 공부의 중간부위 양쪽에 갑상연골의 下角과 결합하는 관절면이 있는데 이 2쌍의 관절만이 후두를 포함한 全氣道에서 볼 수 있는 관절. 이것을 이용하여 성대가 긴장하거나 이동.

☞ 윤상연골이 중요한 이유:

- 윤상연골은 후두의 기초를 이루며 기관의 형태를 유지해줌 → 기관을 절개할 때 이 연골을 자르면 기관 캐놀라 발거곤란증이 올 수 있으므로 주의
- ∴ 기관 절개 시 윤상연골과 제1 기관연골 사이를 목표로 시행해야 한다.

(3) 披裂軟骨(arytenoid cartilage)

- 底部가 윤상연골판부 상연에서 관절면을 형성. 첨단이 상내방으로 향하는 4개면을 가진 3角錘狀.
- 성대돌기: 기저부의 양끝에서 앞으로 두드러진 부위로 진성대가 여기에 부착됨

(4) 喉頭蓋軟骨(epiglottic cartilage)

- 후두입구부 앞에 위치. 木葉狀. 갑상연골 절흔 바로밑 갑상연골내면에 부착.

- 후두강을 덮어주는 기능

*두경 역할: 음식물이 후두로 넘어가는 것을 방지해주는 방어 작용!

이외 小角軟骨(corniculate cartilage), 楔狀軟骨(cuneiform cartilage)이 있다. 소각연골 등은 흔적만 남아있음.

(5) 舌骨(hyoid bone)

- 일반적으로 후두에 포함시키지는 않으나 임상적으로 중요.
- 구조는 본체와 2개의 大角, 2개의 小角으로 구성.
- 嚥下나 發聲시 경부의 위치를 유지하며 후두를 올리거나 내리는데 관여.
- 설골은 후두쪽은 아니지만, 후두를 들어올렸다 내렸다 --> 움직임을 도와준다.
- 후두개연골에 염증성 질환이 생기면 음식물이나 침을 삼킬 때 아프고 기능이 마비되면 음식물을 먹을 때 음식물이 호흡기도를 자극해 기침이 나고 넘기기가 힘들게 된다.

2) 喉頭筋(후두근)

☞ 근육 다 외을 필요는 없다!

- 外喉頭筋, 內喉頭筋.
- ① 외후두근: 후두 주위조직에 부착. 후두를 전체적으로 이동(상승 및 하강)시키는데 관여. 하강(홍골갑상근, 홍골설골근, 견갑설골근), 상승(이복근, 경돌설골근, 이설골근, 악설골근).
- ② 내후두근: 후두에 국한하여 부착. 후두전정과 성문열의 크기를 변화, 또한 성대의 길이와 위치를 변화시키는 작용. 외전근, 내전근, 긴장근으로 구성. 9쌍의 근육과 1개의 단근(피열근 이외에는 모두 쌍으로 구성)

3) 喉頭靱帶(후두인대)

- 후두연골을 연결하고 후두에 부착되어진 인대. 윤상갑상인대, 성대인대, 실인대 등
- 성대인대는 피열연골의 성대돌기와 갑상연골의 내측을 연결.

4) 喉頭の 神經, 血管, 淋巴, 粘膜

- (1) 神經 - 미주신경의 분지인 상후두신경과 하후두신경의 지배.
- (2) 血管 - 상후두동맥과 후두정맥.
- (3) 淋巴 - 聲帶를 제외한 후두 전역에 걸쳐서 풍부하게 분포.
- (4) 粘膜
- 후두의 상부는 후두점막으로, 하인두의 아래는 기관점막에 연속.
- 점액선은 성대의 윗면에는 결핍되어 있으나 다른 부분은 풍부하게 분포.

5) 喉頭腔(laryngeal cavity)

★ 이물흡인 호발 부위 3개 이상 (04) 답: 구개편도, 인두측삭, 이상와 미 후두개곡

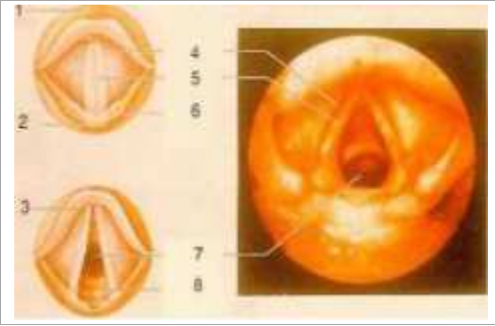
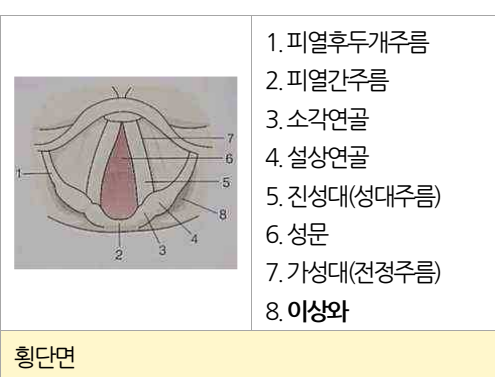
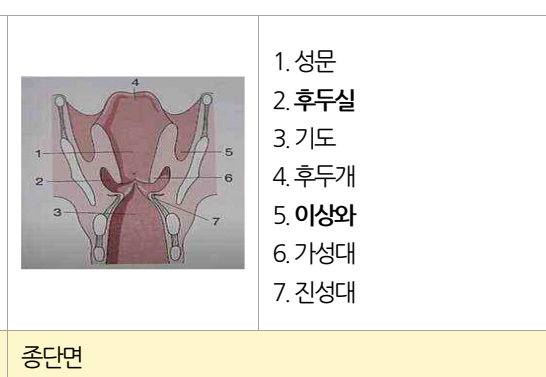
★ 후두 천정의 양 옆이고 해부학적으로는 하인두에 속한다. 함몰되어 있어 이물질이 잘 걸리는 부위는?(13,11,10) 답: 이상와

★ 후두의 양쪽에서 식도로 이행하는 함몰부로 후두 전정의 측면에 위치하며 임상적으로 하인두에 포함시키나 해부학상 후두의 일부분으로 이물이 잘 들어가는 부위는? (15) 답: 이상와

★ 후두강에서 가성대와 진성대 사이 (빈) 공간의 명칭은? (17,14,12) 답: 후두실

- 후두강은 후두연골, 인대, 근육에 둘러싸여진 내측의 공간.
- 발성작용을 하는 聲帶(Vocal cord)가 위치.
- 후두강의 상부는 후두구를 통하여 하인두와, 하부는 피열연골의하단까지를포함.
- 진성대와 가성대로 구분.
- ① 眞聲帶(true vocal cord): 성대후벽. 전 2/3는 막으로 후 1/3은 연골로 구성.
- ② 假聲帶(false vocal cord): 실추벽(vestibular fold). 앞쪽은 갑상연골에서 시작하여 뒤쪽은 피열연골에이르는 부위.
- ③ 후두실(laryngeal ventricle; Morgagni's ventricle): 가성대와 진성대 사이.
- ④ 이상와(pyriform fossa): 후두 전정(vestibule)의 측면에 위치. 임상적으로 하인두에 포함시키나 해부학상 후두의 일부분.
- 성대의 막성부분은 탄성원추에 의해 형성.

★ 발성기관(후두강) 해부도(04)

	1.설저부 2.소각연골 3.후두개 4.실주름(가성대) 5.성대주름(진성대) 6.설상연골 7.성문 8.기관내벽
 1.피열후두개주름 2.피열간주름 3.소각연골 4.설상연골 5.진성대(성대주름) 6.성문 7.가성대(전정주름) 8.이상와	 1.성문 2.후두실 3.기도 4.후두개 5.이상와 6.가성대 7.진성대
횡단면	중단면

2. 기능

① 호흡작용 ② 방어작용 ③ 발성작용 ④ 연하작용

- 발생학적으로 후두의 기본적인 기능은 호흡 및 방어작용이고 발성작용은 2차적인 것.
발성작용이 제일 중요!!

1) 호흡작용(respiratory function)

- 후두는 인두로부터 기관에 이르는 공기의 통로. 단단한 基幹으로 구성되고 넓게 개방된 관. 聲門裂은 가장 협소하며 성대운동으로써 개폐됨.
- 성문은 안정 흡기시 약간 개대, 안정 호기시 약간 폐쇄. 또 심호흡시는 현저하게 개대되어 다량의 흡식기류를 쉽사리 들여보냄. 이런 작용은 혈액속의 이산화탄소의 교환을 조절하고, 혈액과 조직의 산성상태를 유지하는데 관계되는 것임.

2) 방어작용(protective function)

- 하기도에 대해서 폐쇄판의 작용, 기관으로 음식물이나 이물이 들어가는 것을 방지하거나, 또는 들어간 이물을 배출하기 위해 기침반사, 후두구의 폐쇄, 후두강을 수축.
- ① 후두구의 폐쇄 ② 후두강의 수축 ③ 기침반사

3) 발성작용(phonatory function)

- 후두강내 성대의 작용. 후두에서 발생하는 음성은 언어와 노래의 기초가 됨.
- 하부공명기인 흉곽, 기관 및 기관지와 상부공명기인 인두, 구강, 비강, 부비동으로 전파되어 변화와 공명을 일으켜 회화음이 되나 반드시 성대가 회화의 필수 불가결한 것은 아님.
- 고음(1mm, 진동수 다, 단순 횡운동), 저음(3mm, 진동수 소, 성대전체 진동)

- 후두의 음성발생 기전 ④ 인두와 후두의 차이: 인두 = 공명 / 후두 = 발성

- ① 성대가 적당히 긴장, 접근
- ② 호기로 인해 공기가 아래에서 위로 압출
- ③ 성대의 자유연을 진동시켜 음파가 공명기로 전달

- 성대가 진동을 일으키는데 필요한 세가지 조건 ★ 탈기대비

- ① 성대의 양단에서 접촉하는 것 이외는 어떤 조직과도 접촉해서는 안됨
- ② 성대는 좌우측이 서로 밀접해야 이것으로 호기류는 저항에 부딪쳐서 진동이 일어남.
- ③ 성대는 긴장하고 단단해야 된다.

4) 연하작용(deglutitory function)

- 기계적으로 보조역할을 함.
- 연하작용시에 윤상연골과 갑상연골로부터 올라오는 하인두수축근은 후두를 들어올려 식도를 잡아 내려오도록 함
- 더불어 후두 입구의 수축과 후두개연골의 보호로 후두강으로 誤嚥됨을 방지
- 이외 후두는 흉곽의 고정작용과 폐의 혈액순환 작용에 관여

제2장

인후의 생리

교수님 왁: 생리 쪽은 설명할 게 크게 없조~
(기출만 봐도 될 듯!)

1. 五臟六腑와의 關係

1) 咽喉와 肺의 關係

- 肺는 氣를 주관하고 인후와 연결되기 때문에 肺熱로 진액을 손상하거나 혹은 肺癆가 있는 경우 火熱이 직접 인후에 침입되면서 인건, 인통, 궤란, 嚔聲 등의 증상이 발생한다. 아울러 폐기가 허해지면 말소리가 낮고 약해지며 말할 때 힘이 없다.

2) 咽喉와 脾胃의 關係

- 脾는 수곡을 저장하고 정미로운 물질을 생화하여 전신에 공급하므로 사람의 생명활동에서 기본이 된다. 따라서 脾胃에 열이 있어 火熱이 위로 올라가면 목구멍이 붉게 붓고 아프며 음식물을 삼키기 어렵다. 만일 脾가 虛寒하면 입술과 입안이 창백하고 음식을 먹을 생각이 없게 된다.

- 胃는 위로 식도를 거쳐 인두와 연계되며 음식이 통하는 길이다.

3) 咽喉와 腎과 關係

- 腎은 水와 火가 있는 장기인데, 만일 勞傷過度로 陰精을 소모하면 水火의 균형이 파탄되고 虛火가 上炎하면서 인후통과 경한 발적, 종창 및 조열, 顙骨部 발적, 심할 때는 실음 등의 증상이 나타난다.

- 膀胱은 腎과 서로 표리관계에 있으므로 만약 방광에 쌓인 열이 있으면 기화작용에 장애가 일어나고 진액이 줄어들게 되면서 인후의 종창, 동통 및 口糜 증후가 나타난다.

4) 咽喉와 肝膽과 關係

- 肝은 風木의 장기로서 條達하는 것이 생리적 현상인바, 만일 七情의 손상으로 이러한 기능이 장애되면 울결되면서 火熱을 발생하게 되어 결국 口苦, 인건, 인통, 실음 등의 증상이 나타난다.

- 膽은 肝과 서로 표리관계에 있으므로 맺힌 열이 풀리지 않으면 화열이 동시에 왕성하여 上蒸하게 되므로 한숨을 잘 쉬고 口苦, 치통, 침을 자주 뱉는 증후가 나타난다.

2. 經絡과의 關係

★ ()에 들어갈 경락을 쓰시오.(17,14,13,10) 답: 수궐음심포경, 족태양방광경

인후와 경락과의 관계에서 인후는 경맥이 순환하다가 교회하는 곳으로, ()과 ()이 간접적으로 인후와 통하는 것을 제외하고는 나머지 경락 모두가 직접적으로 인후와 통해 있다.

- 생리적인 관계: 《儒門事親》에서는 “推十二經 惟足太陽別項下 其餘皆湊于喉嚨”,이라 하여 咽喉는 經脈이 순환하다가 交會하는 곳으로 십이경락 중에 手厥陰心包經과 足太陽膀胱經이 간접적으

로 咽喉와 통하는 것을 제외하고는 나머지 經絡 모두가 직접적으로 咽喉와 통해 있다.
 실증 :폐위적열 / 허증: 폐신음허

제 3장 인후의 병인과 병리

1. 咽喉病의 病因

★ 인후질환의 주된 병증은 () 위주이고, 장부는 () 위주이다. (14,13,12,11)

《素問·厥論》《靈樞·憂患無言論》 등에서 咽喉病은 陰陽偏勝과 上逆으로 나타나는데, 外因은 時氣 邪毒이나 火熱邪毒이 침범하여, 內因은 胃熱, 心火, 肺胃虛火, 腎虛, 肝膽鬱滯에서 주로 발생되며 大小腸, 三焦, 心包, 胃, 心, 腎經의 所生病으로, 또 運氣의인 변화에서 발생된다 하였다.

인후질환은 주로 火熱證爲主, 肺胃爲主.

- 1) 외인 - 주로 風熱, 風寒, 濕熱, 燥邪와 疫毒邪氣가 침범 火熱로 발병
- 2) 내인 - 주로 肝, 脾胃, 肺, 腎의 기능실조로 肝氣鬱結, 脾胃熱盛, 肺臟虛損, 腎陰虧損되어 나타나며 外因과 마찬가지로 火熱로 발병
 - 肺, 胃, 脾의 기능실조로 인한 것은 주로 實證.
 - 肝, 腎의 기능실조로 인한 것은 주로 虛證.
- 3) 불내외인
 - 노권으로 기혈부족, 음식부절로 脾胃虛弱, 또는 脾胃蘊熱로 積熱이 인후에 上攻하여 혹은 寒濕이 內生되어 발생
 - 寒凉한 약물을 과다 복용하여 腎臟虛損으로도 발생

2. 咽喉病의 病理

- 1) 外感侵襲 2) 疫癘邪毒의 侵犯 3) 脾胃熱盛 4) 肺腎陰虛 5) 氣鬱痰結

제 4 장 검사와 진단

1. 검사

가. 問診

- 직업, 성별, 연령, 과거력, 가족력을 확인
- 직업적 음성을 많이 사용하거나 한냉 습윤한 장소, 자극적인 가스 혹은 먼지 속에서 활동하는 사람 : 편도염, 과립성 인두염, 후두결절
- 과다한 각연, 과음을 많이 하는 남자 : 비후성 인두염, 인두백색 각화증, 악성종양
- 여성: 월경때 인두에 종창이 있어 인두 증상을 호소, 갱년기에 히스테리구(globus hystericus)와 같은 신경성 질환이 자주 발생
- 소아기: 편도임파조직 발육
- 고혈압, 당뇨병, 신장염 환자: 만성 인두염, 중추마비를 동반한 인두마비

나. 望診 및 觸診

1) 上咽喉檢査

- 비인강검사법으로 비강 점막을 강하게 수축시킨 후 비강을 통하여 또는 설압자로 혀를 누르고 거울면을 댄 작은 후비경으로 상인두천개, 이관인두구, 비중격후단, 후비공을 관찰.
 - 촉진방법: 수지검사법. 환자의 오른쪽에서 왼손으로 머리를 고정시킨 뒤 오른쪽 집게손가락을 상인두에 삽입하여 촉진.
 - 환자의 자세
- 아이가 발버둥치지 못하게, 꼼짝못하게 잡아두라는 이야기
- ① 성인: 구역반사(gag reflex)가 일어나기 쉬우므로 긴장을 풀게 하고 머리는 검사자가 원하는 위치로 두게 하며 목을 이완시킨다.
 - ② 소아: 조수의 오른쪽 무릎에 앉혀 환자의 두 다리를 조수의 왼쪽다리로 고정시키고 왼쪽

손으로 환자의 두손을 흉부에 고정하고 오른쪽 손으로 환자의 머리를 검사자가 원하는 위치에 고정시킨다.

<視診>

- ◎ 어린이가 입을 벌린 상태에서 둔한 표정, 치아가 고르지 못한 것, 발음이 명확하지 못한 것이 있음 - **인두편도증식증** 의심
- ◎ 일반상태가 매우 중하고 얼굴이 창백하며 턱밑림프절이 커지고 목소리가 쉼 경우 - **디프테리아** 의심
- ◎ 불안해하며 목을 약간 뒤로 제치고 침을 흘리면서 가늘고 약한 소리로 울 때 - **인두후부 농양** 의심

2) 中咽頭檢査

- 설, 구강, 인두, 구협, 인두측삭을 관찰.
- 방법: 입을 벌리게 한 뒤, 왼손 제1~3지로 설압자를 잡아 혀의 가장 높은 곳 즉 앞 2/3 부분을 서서히 힘을 주면서 전하방으로 누름. 이 때 왼손 제4~5지는 환자의 턱과 얼굴을 지지하여 설압자를 고정하고 구호흡을 시키든지 혹은 “아”, “애” 소리를 내게 함.
- 扁桃腺이 口蓋弓에서 얼마나 돌출되었나에 따라 비대의 정도를 표시
- ① 제1도 비대: 구개궁에서 조금 돌출한 것
- ② 제2도 비대: 중간 상태
- ③ 제3도 비대: 정중선에서 양쪽 편도선이 접촉될 정도인 것
- 편도, 인두 표면의 꺾임 유무 관찰
- ① 백태: 인두디프테리아, 선화성 편도염, 여포 성 편도염, 성홍열성 편도염 등.

② 흑갈색의 태: 혈액질환, 전신쇠약증, 국소 병변의 중증 및 혼합 감염으로 인한 괴저성 편도염, 악성 흑색종, Wegener 육아종 등.

3) 咽頭側索檢査

- 후구개궁을 구개궁구로 당기면 인두측삭이 관찰.
- 측삭은 종종 후비루에 의해 측삭성 인두염이 나타나기도 하고 인두 후벽에 반구상의 팽윤이 발생하는 인후농양(retropharyngeal abscess)이 발생.

4) 후두의 외부

★ 수1,2지로 갑상연골을 잡고 흔들면 정상후두에서는 갑상연골 뒷부분과 경추체가 부딪혀 염발음이 발생한다. 이 현상은? (15)

- 연골막의 비후, 연골막염, 연골괴사, 주위림프절의 종창 등을 진찰.
- **Moure's sign**: 1,2지로 갑상연골을 잡고 좌우로 움직이면 정상후두에서 갑상연골의 뒷부분과 경추체가 부딪치면서 염발음이 나는 것

5) 하인두 및 후두검사

- 설근을 강하게 압박하여 볼 수 있으나 자세한 것은 Flatau 인후경, 후두경, 후두직달경을 사용하는데 이것은 주로 후두검사법에 속함.

- 종류

(1) 직접 후두경 검사법

- 금속제의 관으로 된 직달경을 이용하여 직접 후두를 관찰하는 것. 5세 이하의 유아.
- 금기증: 숨이 몹시 찰 때, 심장혈관계통의 심한 변화가 있을 때, 입안, 목구멍 및 후두 입구에 급성 염증, 궤양이 있을 때

(2) 간접 후두경 검사

- 환자는 坐位, 입을 벌려 혀를 내밀게 하고 호흡을 안정시킴
- 환자 혀끝을 gauze로 싸서 왼손 엄지와 2지 혹 3지로 견인
- 다음 오른손에 후두경을 가지고 환자의 呼氣로 인한 혼탁을 방지하고자 鏡面을 데운 후 구개수 부근까지 접근
- 후두경을 뒤로 밀어 넣는 동시에 상방으로 연구개를 밀면서 후두경면의 각도를 조절하여 설근부, 후두개곡, 후두개, 하인두후벽을 관찰.

〈간접후두경상의 정상적 소견〉

- 후두경에서 거울면에 비친 후두상의 상부가 후두의 전방에, 하부가 후방에 해당됨.
- 후두개의 유리연의 상부(실제 후두의 전방)가 설근부, 중앙구를 중심으로 위쪽에 좌우 대칭의 울퉁불퉁한 표면을 가진 암자색의 설근편도가 보임.
- 후두개의 하부(실제로는 후방)에 2개의 점막괴가 호흡과 동시에 운동하는 것이 피열연골이며, 피

열연골과 후두개연골 사이에 상하로 주행하는 진주빛의 두 띠가 보이는 것이 성대이다. 성대는 짧고 통통해 보이며 하얗고 윤택이 있는 것이 정상이고 성대 사이가 聲門이다. 성대의 외측에는 황적색을 띠는 가성대가 있다.

〈병적후두경상〉

성대의 운동장애	❶ 반회신경마비 또는 후두근 마비 ❷ 암 ❸ 윤상피열관절경직
성대의 궤양 또는 변연거치상	❶ 암 ❷ 결핵 ❸ 매독
신생물	❶ polyp ❷ 유두종 ❸ 歌人結節(singer's nodule) ❹ 암 ❺ 결핵종 ❻ 고무종(gumma)
성대의 발적	❶ 급성, 만성 카타르성 후두염 ❷ 결핵 ❸ 매독
부종	❶ 결핵 ❷ 암 다같이 후두개. 피열부

6) 방사선검사법

- X선 검사는 인두의 형태적 변화는 물론 기능적 변화, 주위기관 및 뼈의 변화, 이물 등을 관찰하는데 필수적, 후두에서도 각종 연골, 설골, 기관강, 경추 등을 관찰하는 것은 물론, 특히 기관의 검사에 도움

(1) 단순촬영법

① 측면촬영 주로 임상에서는 측면 촬영(CT, 혈관조영법 등)

- 연조직촬영: 인두후벽, 후두개, 피열후두개후벽 등을 관찰
- 고압촬영: 상, 중인두의 공기층, 골조직을 관찰

② 정면촬영: 하인두, 후두 및 식도입구가 관찰. 판독 어려움

- ③ 측방향촬영: 상인두 악성종양의 정확한 위치, 크기 두개내 침입상태를 관찰
- (2) 단층촬영법: 상인두 악성종양의 형태 규명, 주위조직 침범상태 관찰, 종양내부 조직구성 확인
- (3) 혈관조영법: 비인강 섬유종 등 종양의 혈관분포를 파악하여 양성 악성의 감별에 이용
- (4) 건조방사선촬영법: 연조직과 골조직을 비롯 여러가지 미묘한 구조물까지도 자세히 관찰 가능
- (5) 방사선영화촬영법: 인두에서의 연하, 호흡, 구음, 기침, 구토 등 운동상태를 동적으로 관찰

다. 聞診

- 호흡곤란과 천명을 진찰.
- 인두질환에서 나타나는 호흡곤란: 인두농양, 소아에서의 인두편도 비대, 편도주위염.
- 인두에서 나타나는 喘鳴(stridor): 일종에 코를 고는 것
- 후두질환에서 나타나는 호흡곤란(dyspnea)과 喘鳴(stridor)은 불길한 증상

<후두성 호흡곤란의 특징>

- 흡기시 흉강내압의 저하에 따라 흉골상와, 쇄골상와, 늑골 간극의 흡기성 함몰이 발생
- 후두가 흡기시는 아래로, 호기시는 위로 이동하는 후두의 변화가 발생
- 1) 성문 상부나 성문의 협착시 - 흡기성 천명음
- 2) 성문 하부나 기관의 협착시 - 흡기 및 호기 모두에서 천명음
- 3) 이외 동정맥기형이나 혈관종 - 박동성 잡음

2. 진단

가. 輕重診斷

- 輕證: 초기에 咽喉가 紅色을 띠고 疼痛하나 말과 음성은 맑고 裏證을 검하고 있지 않은 것
- 重證: 유행성으로 瘡이 생긴 후 咽喉 간에 毒이 鬱結되어 腫痛, 腐爛 되고 음식섭취가 곤란하며 음성이 나오지 않는 것

나. 順危死證診斷

- 順證: 咽喉가 閉塞 腫痛하고 痰涎을 吐하기는 하지만 음식 섭취는 가능
- 危證: 咽喉가 부어서 완전히 막히고 牙關緊急하고 언어가 말지 못하고 痰으로 막혀 氣急

*아관긴급: 턱관절까지 굳어버림

*인후 질환에서 순증이나, 위증이냐는 음식 섭취가 가능하냐, 아니냐로 따진다!

음식을 섭취할 수 있으면 증상이 심해도 나을 확률이 높다.

다. 咽喉 형태와 색상에 따른 감별진단

- 1) 喉痧 - 咽痛 + 身熱, 痧癍
- 2) 白喉 - 咽喉사이에 白點, 白塊
- 3) 喉風 - 喉內 紅腫 + 外項으로 파급
- 4) 乳蛾 - 咽喉側傍에 蠶蛾狀, 栗狀, 棗狀과 같은 것이 있는 것
- 5) 喉痺 - 喉內 閉鎖 不通
- 6) 喉癰 - 喉間이 紅腫疼痛
- 7) 喉疳 - 喉內가 潰爛, 腐蝕되고 痂皮를 형성

- 8) 喉瘡 - 喉中에 瘡이 형성 *후옹과 비슷
- 9) 喉毒 - 耳前 聽會穴에 癰癰狀과 같은 것이 형성
- 10) 喉癰 - 喉間에 癰이 형성
- 11) 喉疔 - 喉間에 靴釘과 같은 형태가 발생 *악성 종양

제 5장

인후두에 나타나는 일반증상

1. 咽頭痛(sore throat)

- 원인:

- ① **염증**: 인두염, 편도염, 인두 및 편도주위농양, 봉와직염, 인두디프테리아, 결핵, 매독 등
- ② **종양**: 특히 악성 종양시 통증이 심함
- ③ **외상**: 열상, 부식상 등
- ④ **설인신경통, 상인두신경통**: 구개편도 및 하인두부에 일측성, 발작적이면서 간헐적인 격렬한 동통
- ⑤ **이물**: 어골 등이 박혀 심한 자발통과 연하통을 유발

☞ 인후병은 병명보다는 증상을 통해 처리하는 경우가 많다.

ex) 주소증이 인두통이면 제일 먼저 염증을 의심한다. 외상(뜨거운 물, 목이 데임)이나 이물 때문일 수도...신경통일 수도..마지막엔 종양도 의심한다!

(위의 ①~⑤ 순서와 다르지만 설명은 위와 같이 하심!)

2. 知覺異常(paresthesia)

(1) 咽頭疾患

I. 지각장애

① **지각 감퇴 및 소실**: 중추성 및 말초성으로 분류.

- 중추성: 연수뇌와 척추질환에서의 출혈, 연화, 종양과 다발성 경화증, 연수마비
- 말초성: 디프테리아, 각기병, 라병 등으로 삼차신경, 설인신경, 미주신경의 지각신경 장애를 유발
- 이외 히스테리, 신경쇠약에서도 기능적 지각탈실 발생

② **지각과민**: 국소 점막의 염증, 즉 급.만성 카타르 혹은 음주, 담배 등이 원인. 구역반사가 항진되어 약간 건드려도 심한 구역과 구토를 일으킴.

II. 지각장애 외

*지각장애보다는 아래의 이상감각을 호소하는 경우가 더 많다.

③ **이상감각**: 자통감, 작열감, 압박감, 건조감, 이물감, 소양감 등. 주로 이물감을 호소.

- 원인이 되는 국소소견

- ① **형태적 이상**: 설근편도비대, 후두개의 이상, 莖狀突起의 과대발육, 식도계실
- ② **염증**: 만성 인두염, 만성 부비동염, 인두결핵 등
- ③ **종양**: 식도암 초기, 갑상선종 등
- ④ **하인두의 경련, 구강인두의 건조증, 타액분비이상, 인두 및 식도이물 등**
 - 원인이 되는 전신질환: 철결핍성 빈혈, 갱년기의 내분비 이상, 위하수, 고혈압, 자율신경실조, 강박 신경증, 우울증, 불안 신경증, 히스테리 등.

(2) 喉頭疾患

- 지각장애

- ① **지각과민**: 후두의 급.만성염증, 알콜중독, 신경쇠약, 음성 과도 사용 등
- ② **지각감퇴**: 중추성(뇌졸중, 구마비, 히스테리), 말초성(상후두신경의 기질·기능적 장애).
- ③ **지각이상 혹은 이상감각**: 이물감, 협착감, 소양감, 건조감을 호소. 대부분이 후두 검사 소견으로 특별한 것을 보이지 않는 수가 많음. 특히 히스테리球(globus hystericus)에서는 이러한 전형적인 형태를 보임.

3. 發音 및 言語障礙(disturbance of voice)

- 발음장애
- ① 폐색성 鼻聲: 상인두에 염증이나 종양, 종창이 있어 공명관으로 작용하는 비인강의 공명이 불완전하여 “ㄴ”, “ㄹ”, “ㅇ”의 발음이 곤란하게 된 것.
- ② 개방성 鼻聲: 연구개마비, 구개파열, 구개천공으로 발생시에 비인강과 구인두 사이가 차단되지 않아 발생.
- 언어장애: 후두질환에서 주로 성대운동근육의 마비로 발생.

<梅核氣(= 咽頭異物感, 신경인두염, 히스테리구)>

- 대체로 중년여성에게 많으며 피로, 스트레스, 근심 등이 원인
- 역류성 인후염의 한 증상
- 加味四七湯, 半夏厚朴湯 등 사용
- 무엇보다도 환자의 상태를 안심시켜주는 것이 필요
- *매핵기: 양방에서 역류성 후두염
- *위산이 역류하는 원인: 밥 먹고 바로 누움, 스트레스, 예민, 식사 불규칙 등등

4. 嚥下障礙(dysphagia)

- 원인에 따라
- ① 동통성 연하장애: 편도염, 편도주위염, 편도주위농양, 설근농양, 후두개연골농양, 인두 결핵 및 악성 종양시, 연하통 수반.
- ② 구강, 인두, 후두의 국소조건에 의한 것:
유아의 급성 인두편도염 및 소아의 인후농양시, 성인의 종양, 그 외 구개파열, 후두의 선천적·후천적 기형, 타액분비장애, 인두내의 종창, 이물, 경추이상 등의 기계적 장애시. 음식섭취장애가 수반.
- ③ 신경근 장애와 정신장애에 의한 것:
미주신경과 설인신경 마비시, 즉 연구개마비시 비강내 誤嚥이, 상인두신경마비시 기침반사가 소실되어 후두내 誤嚥이 발생. 그 외 구마비, 근무력증, 파상풍, 히스테리 등에서도 발생.
- ④ 식도장애에 의한 것: 식도의 기능장애, 식도이물, 식도암 등.
- 후두질환에서의 연하장애는 흔한 증상이 아님.

<연하통과 연하장애> **동통성 연하장애와 일반적 연하장애를 구분하기!

- 1) 연하통(= 동통성 연하장애): 음식을 삼킬 때 통증을 수반하는 것
 - 2) 연하장애: 음식을 삼키는 것 자체에 어려움을 느끼는 것
- 연하장애와 연하통은 동반되기도 하고 개별적으로 나타나기도 함

5. 呼吸困難(dyspnea) ★★

- 기도의 일부를 형성하는 인두, 후두에 협착이 있을 경우 발생하는 호흡장애.
- 코를 고는 것(snoring): 호흡할 때 생기는 구강과 비인강의 기압차 때문에 수면중에 이완된 연구개가 진동하여 생기는 음으로 깊은 수면 때에 혀가 침하되어 인두강이 협소해지므로 발생. 인두편도비대, 인두종양, 비만한 사람에서의 인두강 협소, 연구개 마비 등. 수면무호흡은 수면 중 무호흡의 발현과 혈액내 산소분압의 변화를 확인
- *코골이가 심하면 수면무호흡증 발생 가능

<인두성 호흡곤란과 후두성 호흡곤란의 감별>

- ★ 후두성 호흡곤란에 대하여 설명하시오. (18)
- ★ 인두성 호흡곤란과 후두성 호흡곤란을 감별하시오. (14,03)
- ★ 후두성 호흡곤란에 대하여 설명하시오. (13,11)
- ★ 코를 고는 것의 기전을 설명하시오. (04)

	인두성 호흡곤란	후두성 호흡곤란
흡기시 후두의 하강	없다	있다
호흡곤란 상태	호기성	흡기성
환자의 두위	전굴상태	후굴상태
음성의 변화	없다	있다
흉골 상·하와의 함몰	뚜렷하지 않음	뚜렷함
특징	☞ 기도의 일부를 형성하는 인두, 후두에 협착이 있을 경우 발생하는 호흡장애 ※ 코를 고는 것(snoring) ☞ 호흡할 때 생기는 구강과 비인강의 기압차 때문에 수면 중에 이완된 연구개가 진동하여 생기는 소리 ☞ 깊은 수면 시 혀가 침하되어 인두강이 협소해지므로 발생 ☞ 인두편도비대, 인두종양, 비만한 사람에서의 인두강 협소, 연구개 마비 등 ☞ 수면무호흡은 수면 중 무호흡의 발현과 혈액 내 산소분압의 변화를 확인	☞ 흡기 시 흉강내압의 저하에 따라 흉골상와, 쇄골상와, 늑골 간극의 흡기성 함몰이 발생 ☞ 후두가 흡기 시 아래로, 호기 시 위로 이동하는 후두의 변화가 발생 • 흡기성 천명음: 성문 상부나 성문의 협착 시 • 흡기, 호기에서 천명음: 성문 하부나 기관의 협착 시 • 박동성 잡음: 이외 동정맥 기형이나 혈관종

6. 口臭

- 원인

- ① 타액분비감소에 의한 점막의 건조: 항히스타민 투여, 수렴제를 사용하여 함수했을 때, 방사선 치료 후 타액선염, Sjögren 증후군 등
- ② 불결한 구강위생: 즉, 식물괴, 불결한 치아
- ③ 방향성 음식
- ④ 충치 + 치근막 병변, 괴사성 치주염, 악성 종양 등
- ⑤ 과량의 껌연
- ⑥ 전신질환: 당뇨병(아세톤 냄새), 요독증(암모니아), 간부전(생선 냄새)

7. 充血과 蒼白

(1) 충혈

- ① 심홍색: 적혈구 및 혈색소가 전신적으로 증가한 경우나 국소 자극(뜨거운 음식 등)으로 국소의 활동성 충혈이 발생한 경우
 - ② 청적색: 심장 판막염, 만성기관지염, 폐기종, 간경변증 등
- (2) 창백: 적혈구 혈색소의 감소, 악성빈혈, 백혈병, 인두결핵 전구증상, 위축성 인두염 등

8. 苔, 斑點, 僞膜(coating, patch, pseudo-membrane)

★ 급성 편도선염과 인두 디프테리아에 대하여 위막의 특징을 비교하여 설명하시오. (17,14,08)

	급성 편도선염	인두 디프테리아
苔, 斑點, 僞膜	- 초기 선와나 여포에 일치하여 나타나나 후에 융합하여 막모양이 되며 편도 밖으로 파급되지 않음..	- 태가 편도에 국한되지 않고 구개궁, 연구개, 인두후벽까지 파급. - 광택이 있는 두꺼운 회백색막으로 박리하기 어렵고 박리하면 출혈.
潰爛	㉠ 경증 ㉡ 환부가 成膿되면서 백막이 일어나는데 성글고 두꺼우나 쉽게 벗겨짐	㉠ 중증 ㉡ 백막이 단단하고 무리하게 떼면 피가 나오거나 벗겨져도 곧 백막이 생김

9. 潰瘍 및 浸潤(咽瘡風) 궤양과 관련된 3가지 감별점은 알아두시는 게 좋아요~

- ① 결핵성: 황색, 회백색의 소결절로 궤양은 얇고 예리한 변연을 가지며 저면은 평활하나 육아가 노출되어 동통이 심함.
 - ② 매독성: 궤양이 깊고 변연이 두터우며 저면에 돼지기름모양의 태를 형성, 동통은 적음. 결핵성과 매독성은 거의 반대 특징
 - ③ 암중: 궤양이 주위로 파급되며 주위와 경계가 뚜렷하지 않고 궤양은 분화구상이며 접촉하면 쉽게 출혈, 동통이 심함.
- 통증성 급성 궤양: 염증 치료에 준하여 利膈湯, 牛蒡子湯 등
- 무통성 만성 궤양: 內傷(歸脾湯), 陽虛(補中益氣湯, 人參養榮湯), 陰虛(六味地黃丸) 등

10. 분비이상

- ① 끈끈한 분비물: 인두염, 편도염
- ② 인후농양: 대량의 거품섞인 분비물
- ③ 분비물 감소: 매독, 결핵, 루프스, 건성 인후염

11. 聽器症狀

- 상인두 질환(아데노이드, 이관편도비대), 이관염증으로 인한 이관폐쇄 → 중이 카타르 → 난청

12. 發熱

- 여포성 및 선와성 편도염과 편도주위염에서 39~40℃의 고열.

13. 出血

- 구강의 외상, 병변, 주위장기의 출혈, 전신성 출혈성 질환으로 발생.
- (1) 외상
 - ① 인두, 혀, 구개편도 절제후
 - ② 마취 삽관, 구개인두 자상
 - ③ 부식상, 열상시
 - (2) 병변
 - ① 급성 편도염, 결핵 등의 염증
 - ② 출혈성 풀립, 악성 종양 등
 - (3) 주위장기의 출혈: 비출혈, 각혈, 토혈

14. 咳嗽

- 기침은 후두질환에서 흔히 볼 수 있는 증상.
 - 발생기전: 국소 점막의 염증, 분비물, 이물의 誤嚥이 이·비·인후부에 분포하는 삼차 및 미주 신경을 자극하여 기침 발생.
 - 咳嗽點: 가장 예민하게 기침을 유발하는 부위. 피열간부, 후두후벽, 기관분기부, 기관후벽 등.
 - 증상에 따라
 - ① 분비물이 많을 때: 濕性 咳嗽(moist cough)
 - ② 분비물이 적을 때: 乾性 咳嗽(dry cough)
 - ③ 犬吠性 咳嗽(barking cough): 후두디프테리아, 크루우프 증후군(성문하점막의 종창)
- ★ Barking cough를 유발하는 대표적인 질환 2가지는? (17)
환자가 왔는데 쾅쾅거리며 기침하면 후두디프테리아, 크루우프 증후군 확인하기! (중요)

15. 喀痰

- 후두염증 초기에는 분비물의 양이 감소되는 것이 보통, 경과에 따라서 증가되기도 함.
- 종류
 - ① 점액성: 일반적인 객담. 후두의 카타르성 염증
 - ② 점액농성: 후두결핵, 후두매독 등에 의한 궤양이나 후두농양
 - ③ 괴저성: 혈성 객담과 악취를 동반하는 악성종양

16. 嚶聲(hoarseness)(애성) ★★

★ 嚶聲(애성)(hoarseness)에 관하여 설명하시오. (00)

★ 嚶聲(애성)을 청각적인 느낌에 따라 3가지로 구분하시오. (00)

- 후두질환에서 가장 자주 볼 수 있는 증상
- 원인이 되는 후두질환
 - ① 후두병변: 염증, 종양, 외상등
 - ② 후두근의 신경지배 장애
 - ③ 발성기관 과로

★ 14, 18 기출(빈칸 채우기)

* 객연(흡연), 음주를 많이 하는 사람이나 40대 이후 남성에서 嚶聲이 자주 반복적으로 나타날 경우 (후두 및 하인두의 악성종양)을 의심해 봐야 한다.

- 상태(청각적인 느낌)에 따라

- ① 기식성 애성: 성대마비의 경우, 즉 양쪽 성대 간격이 넓어서 발생
- ② 조조성 애성: 거친 잡음. 성대 점막부의 표면이 거칠거나 혹은 점막 운동이 제한을 받아서 유발되는데 주로 후두염, 후두폴립, 성대 종양 등에서 발생
- ③ 무력성 애성: 성대근이 약화되는 중증 근무력증, 성대폐쇄부전

17. 喘鳴(stridor)

- 후두성 호흡장애와 동반
- 흡기성
- 환자가 불안정하면 심해짐(빨리 들어간 공기가 성대의 상면을 쳐서 성문개대에 지장을 주어 더욱 심해짐) → 안정을 취하게 함 → 서서히 호흡하도록 지시.

18. 耳痛

- 喉頭痛은 연하시 심해지는데, 흔히 후두통이 귀로 전달되어 耳痛을 호소하는 방사통이 발생하는 것은 미주신경의 분지인 이개신경(Arnold 신경)이 관계함.
- 후두의 급성 염증, 봉와직염, 후두결핵, 종양에 의한 궤양, 후두의 연골막염이나 날카로운 후두이물 등의 경우에 후두통이 발생

제 6 장

치료 및 조호법

1. 治療

★ 인후병 치료에 있어서 火鬱之發의 의미는? (04) 간결한 답은 악마 참고!

《儒門事親》에서는 《黃帝內經》의 “火鬱之發”은 發汗을 의미하는데 發汗을 시키면 誤治가 되므로 發汗 대신에 出血을 시키라 하였으며, 특히 喉痺에서는 瀉血이 최선책이고 또한 咽喉에 鍼瘡이 있을 때는 生薑을 熱湯 調服하라 하였다.

《醫學心悟》《清 沈青芝. 喉科集腋》에서는 咽喉, 口, 舌病의 치료에 있어서 초기에는 疏風解毒시키고 병이 계속되면 滋水養陰하며, 만일 元氣가 점차적으로 虛弱해지면 急히 脾胃를 調養하고 또한 喉腫에 不刺血, 喉風에 不吐痰, 喉癰에 不放膿, 乳蛾에 不鍼破하지 않으면 안 된다 하였다.

가. 일반적 치료

① 咽喉은 호흡, 음식의 門戶로서 유행성 질환이나 病毒에 쉽게 감염되며, 또한 經絡과 氣血이 이곳에서 交會하므로 병리변화와 肺, 胃, 肝, 腎의 모든 經이 밀접한 관련을 가지고 있으며, 치료상에서도 解毒, 疏表, 養陰, 清裏, 解鬱하여야 한다.

② 咽喉病은 腫痛과 痰이 많으므로 行血 導痰法으로 消腫 止痛 祛痰시키고 온수로 양치질 한 후 鍼刺하거나 吹藥을 사용하여 痰涎을 제거한다. 痰涎이 다소 그쳐졌을 때 온수로 자주 양치질 한다.

나. 內治法

- 1) 解表祛風
- 2) 清熱解毒
- 3) 清熱化痰
- 4) 散瘀排膿
- 5) 溫補益氣
- 6) 滋陰養液

* 通便利膈

* 解鬱散結(칠정손상으로 肝氣가 鬱結되거나 또는 기혈이 응체되어 痰涎이 上逆하여 인후를 阻塞시켜서 咯不出, 嚥不下하는 梅核氣가 발생하는 경우)

* 清咽化痰(火熱上炎으로 진액을 灼傷하여 痰涎이 結聚되는 熱痰)

다. 外治法

- 1) 含咽法(丸이나 片으로 만들어 입안에서 오랫동안 머금었다 천천히 삼김)

환자에게 벌떡 먹으라고 하기보다는 편도에 염증이 있을 때 실증약을 사용할 경우 염증부위에 약간 머금게 하기! (함인법 활용)

2) 含漱法(약액으로 구강과 인후병의 환처를 씻어 냄)

3) 吹法(분말한 약을 竹筒이나 갈대통으로 소량씩 인후에 吹入)

4) 薰蒸法(鼻 또는 인후에 증기 흡입 및 煙蒸하는 방법) : 開關法

5) 探吐法(약물을 삼입하여 인후가 자극되어 痰涎을 구토하게함)

6) 外敷法(인후병과 頸項部 외측의 환처에 종창이 있을 경우나 혹은 虛火로 인한 喉痺, 喉風에 약재를 膏로 만들어 敷貼)

〈開關法〉

- 雄黃解毒丸, 龍腦破毒散에 巴豆를 넣고 황색 油紙에 싸서 심지로 만들어 불을 붙여 연기를 코로 흡입하게 하면 鼻口에서 침이나 콧물이 흐르면서 牙關이 열림

- 走馬喉痺에서 사용

라. 鍼灸治療法

1) 鍼刺 :

- 頸項部の 上星, 頰車, 翳風, 風池, 天柱穴.

- 軀幹部の 鳩尾穴

- 上下肢部の 曲池, 合谷, 少商, 少衝, 中衝, 商陽, 關衝, 足三里, 豐隆, 照海, 內庭, 湧泉穴

2) 耳鍼 : 耳尖, 心, 肺, 神門, 腎上腺, 內分泌, 咽喉, 扁桃 1, 2, 3, 4穴點.

3) 瀉血 : 急性的으로 紅腫疼痛, 咽喉阻塞, 呼吸困難이 발생하는 경우

- 양측의 少商, 商陽穴과 十宣穴을 삼능침으로 瀉血시켜 消腫止痛, 解熱.

4) 患處瀉血 : 환부의 紅腫疼痛이 극심하고 병세가 급하면서 堵塞, 呼吸困難이 발생될 경우 - 삼능침으로 紅腫 突起部에 1寸 정도로 깊게 刺入 放血시킴. 咽喉腫痛, 帝鍾風, 腎傷寒에는 禁忌.

5) 灸 :

- 虛火喉痺, 虛火乳蛾 등과 같은 慢性的이고 虛寒性인 咽喉病에 사용

- 肺腎經의 太溪, 照海, 魚際穴과 足三里, 合谷, 曲池, 內庭, 少澤, 湧泉, 外關, 天突에 艾灸

* 烙法

- 熱熨法과 비슷. 주로 石蛾, 虛火乳蛾, 喉痺, 咽瘤, 舌 및 齒牙의 衄血, 出血된 患處가 止血이 되지 않을 경우에 使用.

- 三稜鍼에 熱을 가해 달구어 香油나 酒精을 묻힌 後에 신속하게 患部를 지진다. 每日 10~20번을 실시. 急性 咽喉病, 高熱, 咽喉腫痛, 血瘤에는 절대 禁.

2. 調護法

1) 食生活

- 위산역류는 인후 질환의 많은 원인이 되기도 한다.
- 평상시 자극적인 음식, 매운음식, 지나치게 뜨겁거나 찬음식 등을 피하는 것이 좋다.

2) 環境

- 평상시 습도관리에 주의. 건조한 환경을 피한다.
- 피로는 인후병을 더욱 악화시킨다.

3) 發聲

- 평상시 목에 힘을 주지 않고 말하는 습관을 기르고 소리를 지르지 않는다.

4) 水分攝取

- 인후의 건조 및 부종을 막기 위해서는 규칙적인 수분섭취가 필요하다.
- 한 번에 많은 양의 수분을 섭취하기 보다는 수시로 적은 양의 수분을 계속해서 섭취하는 것이 더 좋다.

發聲의 機能 *올해 수업은 거의 언급 안 하셨지만 선배들이 강조해놓은 내용!

- “張志聰 經曰 音聲之器 在心主言 在肺主聲 然由腎間動氣 上出於舌 而後能發其聲音”이라 하여 五臟에서 音聲이 發하나 그 根本은 腎主納氣로 腎에 있으며 心神의 作用으로 心에서 言語를 주관하고 肺主諸氣로 肺는 소리를 주관한다 하여 音聲의 機能은 肺, 心, 腎과 밀접한 關係가 있음을 나타냈다.

(변증에서는 폐, 신을 주로 이야기하는데 심리적인 요소인 심도 추가해 고려해야 함.)

<咽喉病의 辨證 및 診斷>

1. 疼痛

- 초기에 紅腫疼痛한 것은 風熱邪毒, 或 肺經有熱이고,
- 咽喉微痛 혹은 不適하고 淡紅不腫한 것은 風寒邪毒의 침입이며,
- 疼痛과 紅腫突起가 甚해지는 것은 熱毒이 裏證으로 轉變, 或 肺胃熱毒이 壅盛하여 발생.
- 咽喉에 微痛 혹은 不適, 微紅腫하고 病程이 오랫동안 지속되면서 아침에는 輕하나 저녁에 甚해지는 것은 腎陰虛로 陰液不足되어서 虛火上炎된 것이고,
- 咽喉가 乾燥, 癢痒하면서 咳嗽가 兼하여 나타나면 肺津耗傷으로 陰虛肺燥, 氣虧된 것이다.

2. 紅腫

- 疼痛 참조.
- 돌연히 高腫이 일어나면서 色紅暗, 脹痛이 있고 血腫도 兼한 것은 血分積熱,
- 표면이 光滑하고 腫塊緩慢, 長大하면서 質硬不痛한 것은 氣血凝聚, 痰濁結聚로 瘤腫,
- 表面光滑, 紅赤, 潰爛한 증상이 주위에까지 粘連되는 것은 癌腫.

3. 潰爛

- 초기에 潰爛이 표면에 분포되면서 紅色을 띠는 것은 風邪熱毒이 침범한 肺經熱盛,
- 병정이 오랫동안 지속되고 반복적으로 潰爛淺表, 微紅腫이 발생되면서 특히 식사시 刺痛이 일어나는 것은 心脾兩虛나 陰虛火旺.
- 潰爛이 오래되어 표면이 울퉁불퉁하고, 변연이 깨끗하지 못하며 疼痛, 咽喉乾燥, 癢痒, 咳嗽가 있는 것은 肺腎陰虛와 肺燥津虧한 喉癰.
- 환부가 成膿되면서 白膜이 일어나는데 성글고 두꺼우나 쉽게 벗겨지면 輕症이고 白膜이 단단하고 무리하게 떼면 피가 나오거나 벗겨져도 곧 白膜이 생기는 것은 重症.

(앞서 정리한 편도선염과 인두디프테리아의 감별 point 중 하나!)

4. 乾燥, 癢痒, 焮熱

- 咽乾
- ① 實證 咽乾: 肺胃熱盛 혹은 風熱邪毒이 침입하여 傷耗津液된 것. 喜飲
- ② 虛證 咽乾: 肺腎陰虛로 인해 津液이 不足된 것. 不喜飲
- *실증인건은 폐위열성 / 허증인건은 폐신음허
- 焮熱
- ① 實證 焮熱: 邪熱上灼
- ② 虛證 焮熱: 虛火上炎

- 咽痒
- ① 實證 咽痒: 風이나 燥邪의 침입
- ② 虛證 咽痒: 陰虛肺燥

갈증 : 마르고 물이 마시고 싶은 상태 / 건: 마르는데 물을 마시고 싶진 않은 것.

5. 膿液

- 膿液이 稠黃하면 實熱,
- 膿液이 多量이면 濕熱,
- 清稀하면 虛症.
- 咽喉가 발적, 종창되고 파동이 있으며 눌러볼 때 말랑말랑하면서 움푹 들어가는 것은 膿液이 이미 형성된 것이고, 눌러보아 단단한 것은 아직 膿液이 형성되지 않은 상태.

6. 閉塞感

- 堵塞感이 있으면서 吞咽不利 혹은 困難, 紅腫痛이 발생: 肺胃熱盛
- 嚥下에는 이상이 없으나 異物感和 哽哽不利, 淡紅色을 띠는 것: 肺腎陰虛로 虛火上炎
- 異物感和 喀吐不出이 음식을 삼키는 데는 장애가 없으나 신경을 쓰면 더욱 심해지는 것: 肝氣鬱結로 氣痰交阻한 것
- 甚하게 閉塞感을 느끼고 呼吸도 원활치 않으면서 吞咽하면 嘔吐가 발생하는 것: 痰濁結聚나 癌腫에서 발생

7. 形態

- 喉痧: 痧癍이 발생.
- 喉癢: 咽喉痛과 發熱이 있으면서 瘡이 일어나는 것.
- 喉癰: 苔蘚이 나타나는 것.
- 喉疳: 咽喉에 潰爛, 腐蝕되어 痂皮가 蝦皮狀을 띠는 것.
- 喉癰: 咽喉에 紅腫疼痛이甚한 것.
- 喉疔: 靴釘과 같은 疔瘡이 咽喉에 발생.
- 喉瘤: 咽喉兩傍에 圓眼狀이 발생.
- 白喉: 咽喉間에 白點, 白條, 白塊가 나타나는 것.
- 乳蛾: 咽喉側方에 蠶蛾狀, 栗狀, 棗狀이 발생.
- 1) 單蛾: 종대가 偏側
- 2) 雙蛾: 종대가 兩側
- 3) 虛火乳蛾: 肺腎陰虛로 인해 虛火上炎이 오랫동안 반복적으로 발생
- 4) 石蛾: 乳蛾가 항시 종대되어 있으나 不紅不腫함
- 喉痺: 喉內가 閉塞되어 咽喉 不通.
- 風熱喉痺(=紅喉): 咽喉가 紅腫灼痛, 吞咽不利하면서 風熱表證과 兼함
- 風寒喉痺: 淡紅不腫, 微痛, 吞咽不順, 惡寒, 頭痛이 발생
- 虛火喉痺: 微痛, 癢痒, 異物感和 灼熱感, 건조한 것이 오후에 심함
- 喉風: 喉內가 紅腫되어 外側 頸項部로 파급되면서 閉塞 발생.
- 緊喉風: 咽喉腫痛이 급속히 발생, 呼吸不利, 言語困難, 痰涎壅盛이 발생
- 鎖喉風: 증상이 극심해져 牙關緊急과 口噤이 마치 鎖한 것 같음
- 纏喉風: 喉內에 紅腫, 疼痛이 심하고 국소에 糜爛까지 발생하는 急症
- 喉毒: 耳前 聽會穴 부근에 瘰癧狀과 같은 것이 나타나는 것.

8. 聲音

1) 五音과 五聲의 變化

2) 聲音의 高低

- 高低에 따라 實證과 虛證으로 진단

① 虛寒: 《東垣十書》에서 “內傷飲食勞役者 心肺之氣先損……其氣亦怯 其聲亦低 是其氣短少不足之驗也”라 하여 陽衰陰盛하고 陰主靜하여 機能이 低下.

② 實熱: 《東垣十書》에서 “心肺元氣 初無減損 又添邪氣助之……其聲壯厲而有力者 乃有餘之驗也”라 하여 陽盛氣實하고 陽主動하여 機能이 亢進.

3) 音聲의 變化

- 音啞: 聲音이 嘶啞한 것으로 목소리가 쉬고 잘 나오지 않는 不清인 상태

- 失音(= 瘖瘖, 聲啞, 聲不出)은 전혀 발음을 하지 못하는 發聲不出

- 聲音病: 주로 肺, 腎과 관련된 병변. 虛實證으로 분류.

★ 金實不鳴과 金破不鳴을 설명하시오. (00)

	金實	金破
양상	실증, 돌연히 발병, 병이 表에 있음	허증, 점진적으로 발병, 오랫동안 잘 낫지 않음, 병이 本에 있음
원인	- 外邪가 肺에 壅滯된 金實不鳴. - 風寒, 風熱邪가 咽喉에 客하여 발생	- 肺燥傷津, 虛火灼肺, 肺腎陰虛 - 津液이 上榮 못하여 발생
증상	- 聲音이 重濁, 發音困難 - 咽喉乾燥, 疼痛, 口渴, 黃色 粘糟한 痰이 出하며 舌苔黃膩, 滑數脈	- 聲音이 低微하면서 점차적으로 重濁해짐 - 懶言, 聲疲勞感, 氣短乏力, 口乾, 咳嗽, 咽痒微痛, 咽喉淡紅, 舌質紅, 舌苔少, 細數脈.

9. 脈診

《醫學正傳》에서는 兩側의 寸脈이 浮洪하면서 溢하면 喉痺이고 脈이 微하면서 伏하면 死한다 하였다.

《證治匯補》에서는 二寸脈이 浮洪 或은 溢하면 喉痺이고, 二尺脈이 微細無力한 것은 虛火이며, 微脈이 甚하게 나타면서 伏脈을 띠면 死症이다. 또한 浮大하면서 溢脈이 나타나는 것도 死亡하게 된다 하였다.

10. 咽喉病의 輕重, 生死鑑別

《尤氏喉科秘節》에서는 大便通利의 與否로 輕重을 鑑別하는데 不通이면 實火로 重症이고 便通이면 虛火로 輕症이며, 또한 重症은 病程이 이미 오래되어서 虛火上升과 營血이 已竭된 것이라 하였다.

《外科正宗》에서는 초기에 咽喉가 紅色腫痛되어 半閉半開하고 痰涎喀吐하나 음식을 잘 삼킬 수 있으면 順症이고 咽喉腫閉, 牙關緊急, 言語不清, 痰壅氣急, 聲音小하게 나타나는 것은 險症이며 만일 咽喉驟閉, 痰涎壅塞, 口噤不開, 探吐不出, 聲音喘한 것은 死症이라 하였다.

*인후병의 경증 vs 중증: 음식을 잘 섭취하나, 대변이 잘 통하나 등의 기준!

+) 맹장염 심해지면 대변이 잘 안 나옴!

《喉科秘旨. 卷之一》에서는 四絶症으로 走馬喉風, 鎖喉風, 走馬牙疳, 纏喉風이 있으며, 十六絶形에는 舌捲囊縮, 角弓反張, 油汗如珠, 十指無血, 喉啞噎食, 喉乾無痰, 吐血喉癰, 六脈沈細, 聲如踞拽, 大便十日不通, 鼻煽脣清, 天柱倒榻, 脈細身凉, 兩目直視, 壅痰氣塞, 喉菌不治가 있는데 특히 纏喉風과 陰虛喉癰은 매우 危險하다 하였다.

〈인후 불치증〉

1. 국부증상

- 경부의 발적과 종창이 흉부에까지 미치는 경우
- 인후 병조에서 지속적으로 출혈되는 경우
- 고름색이 어두운 색을 띠면서 더럽고 심한 악취가 나는 경우
- 白膜이 인후 전반에 분포되거나 혹 腐爛되면서 깊은 궤양 및 자흑색을 띠는 경우
- 호흡곤란이 심한 경우
- 완전히 실음 상태에 빠지는 경우
- 음식물을 삼키기 곤란한 경우

2. 전신증상

- 의식이 흐리고 고열, 전율이 지속되는 경우
- 牙關緊閉가 있는 경우
- 양안 直視와 구슬 같은 땀이 나오는 경우
- 가래가 많고 숨이 차거나 혹 톱질하는 소리와 유사한 가래소리가 나는 경우
- 비익 호흡이 있으면서 脣靑한 경우
- 비강이 건조하고 매연에 그을린 상태와 유사한 경우